

21. LE LIG LILIEQUIST'S

DURÉE : 07:37

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore l'anatomie et les mécanismes du ligament liliequist, une structure essentielle qui agit comme un diaphragme au niveau du troisième ventricule. On y apprend comment ce ligament interagit avec le nerf oculomoteur et le tronc basilaire, influençant ainsi le système ventriculaire et l'hypophyse. Les concepts de tensions membraneuses, d'axes de mouvement crânien et de leur impact sur les systèmes facial et hormonal sont abordés, tout en soulignant l'importance des mouvements crânio-sterno-sacrés et mandibulaires. L'analyse des tensions peut également aider à diagnostiquer des dysfonctionnements au niveau occlusal, offrant des clés thérapeutiques pour rétablir l'harmonie corporelle.

LE LIGAMENT LILIEQUIST : ANATOMIE ET MÉCANISMES

Le **ligament liliequist** est une structure anatomique qui agit comme un petit diaphragme, communément appelé **membrane de l'iliquiste**. Ce ligament s'insère au niveau du **troisième ventricule** et descend jusqu'au **sphénoïde**.

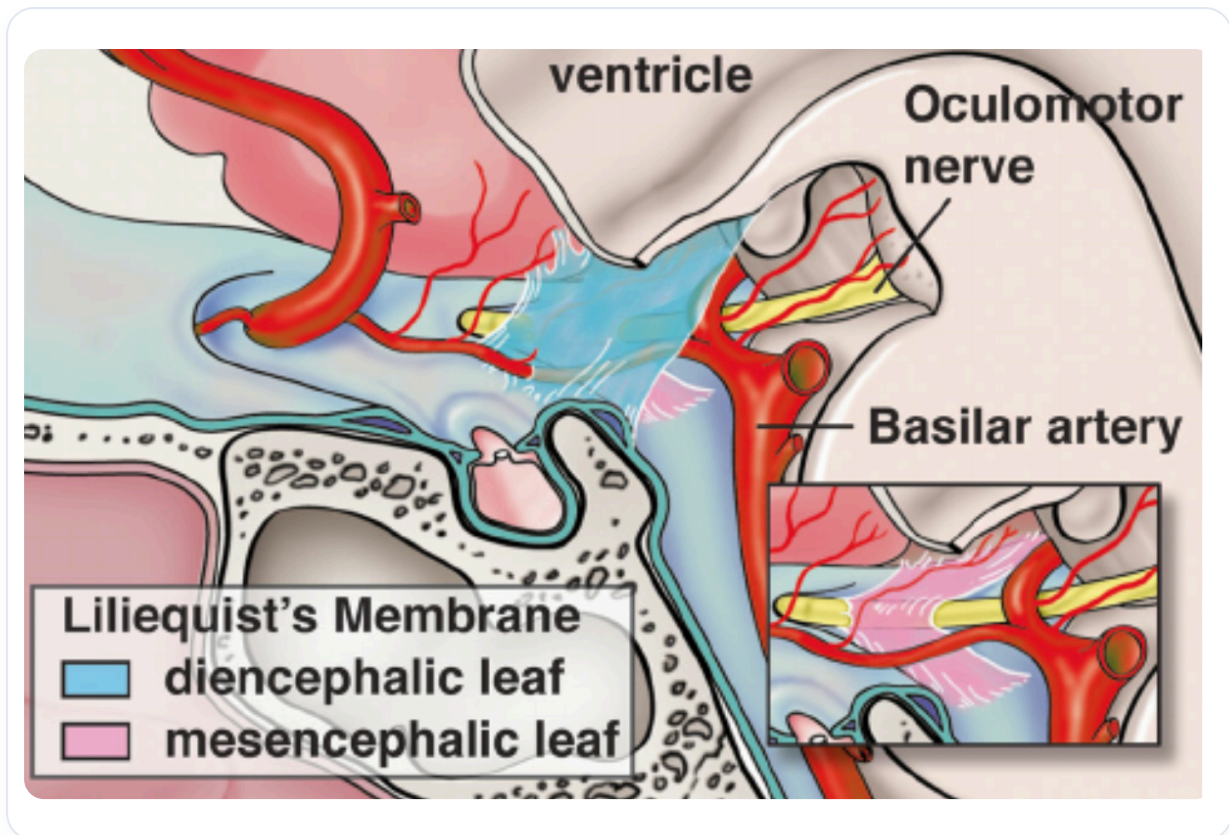


FIG. — Ligament de Liliequist

À cet endroit, il joue un rôle crucial en relation avec le **nerf oculomoteur** et le passage artériel, notamment le **tronc basilaire**, qui est responsable de la formation des **artères cérébrales**.

Lorsque le ligament descend, il crée un **axe de tension** qui influence le **système ventriculaire**. Le troisième ventricule, le quatrième ventricule, ainsi que les **ventricules latéraux** sont tous interconnectés par cette dynamique.

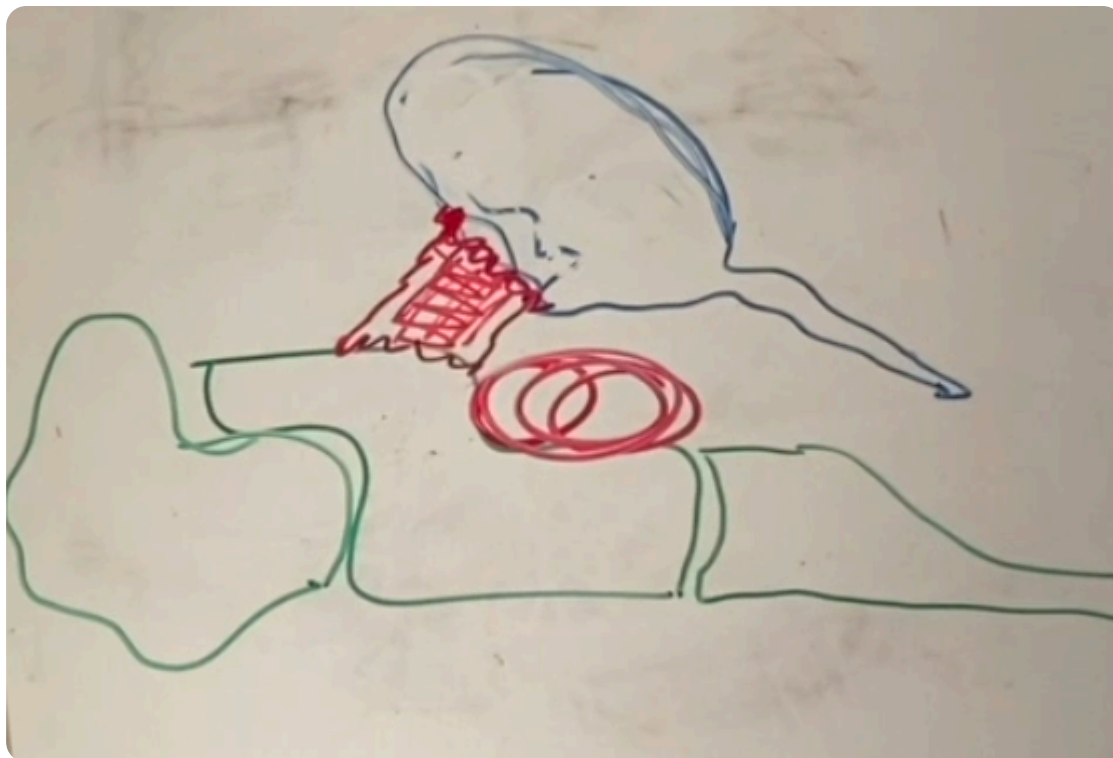


FIG. — Système ventriculaire

Un schéma de tension se met en place, ayant un impact significatif sur l'espace où se trouve l'**hypophyse**.

Au-dessus de l'hypophyse se trouve le **chiasma optique**, qui est orienté à environ 30 degrés, avec un mouvement postural de 5 degrés. Ce mouvement est essentiel pour le **drainage** entre le troisième ventricule, le sphénoïde et les **micro-vaisseaux** environnants. Les **péricytes**, présents dans les microcapillaires, interagissent avec les nerfs, créant des **espaces hémato-encéphaliques** qui agissent comme un point d'appui profond.

En examinant les **présphénoïdes**, qui correspondent à l'**occiput**, on observe un espace de balance sur la membrane de l'iliquiste. Cette tension membraneuse affecte à la fois les nerfs et les vaisseaux sanguins, et se situe à proximité de l'hypophyse, où le système nerveux communique avec le système hormonal via l'**axe hypothalamo-hypophysio-thyroïdo-surenal-gonadique**.

Le mouvement crânien est également important à considérer. En observant un crâne, on peut noter les différents mouvements au niveau des **pariétaux** et d'autres structures.

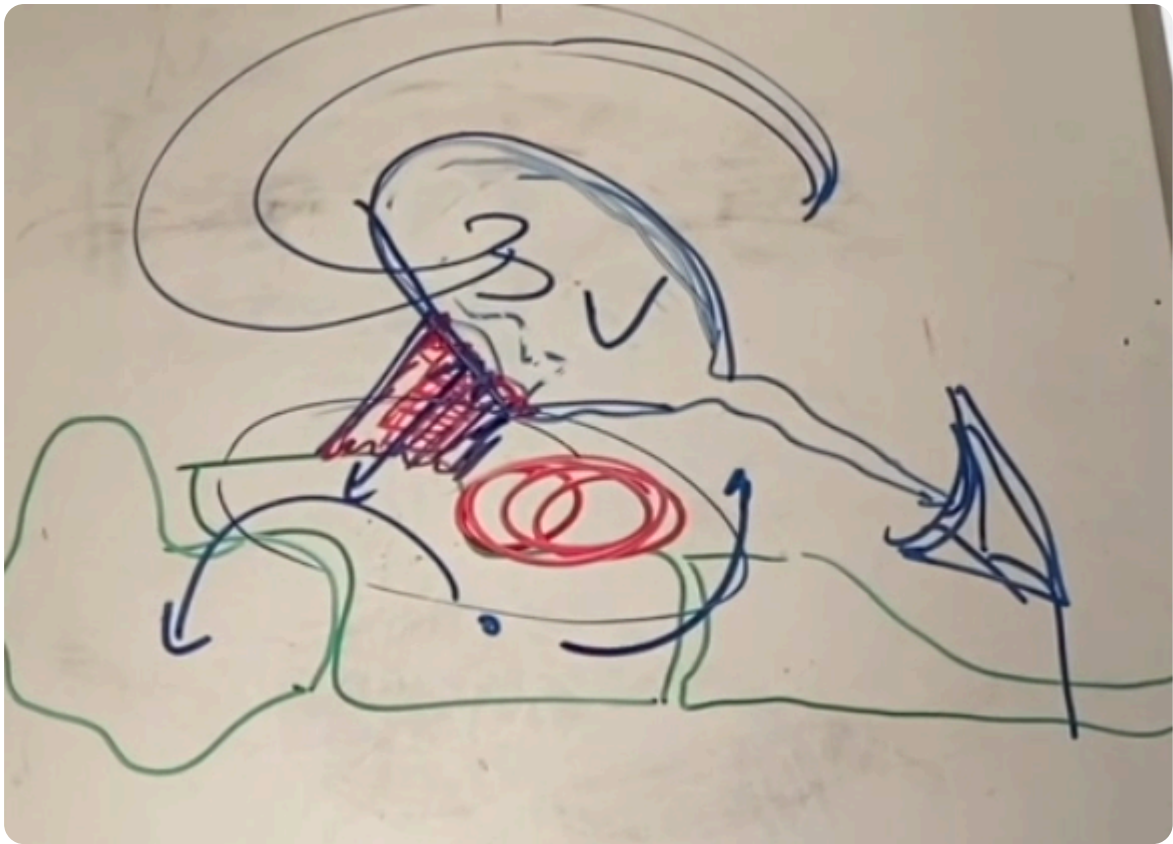


FIG. — *Mouvements crâniens*

Ces mouvements suivent des lignes de force spécifiques. Par exemple, le mouvement de **flexion** au niveau frontal, associé à la **suture métopique**, représente deux points de balance qui influencent le mouvement de l'œil.

Il est crucial de comprendre que le **cerveau** conditionne le **système ventriculaire** et le **système facial**, tant sur le plan du **chondrocrâne** (cartilage) que du **desmocrâne** (membrane). Lors du développement, lorsque l'**occiput** descend, le **sacrum** descend également, et les **temporaux** jouent un rôle clé dans cette dynamique.

Le **sternum** monte en réponse à ces mouvements, convergeant vers la ligne médiane antérieure.

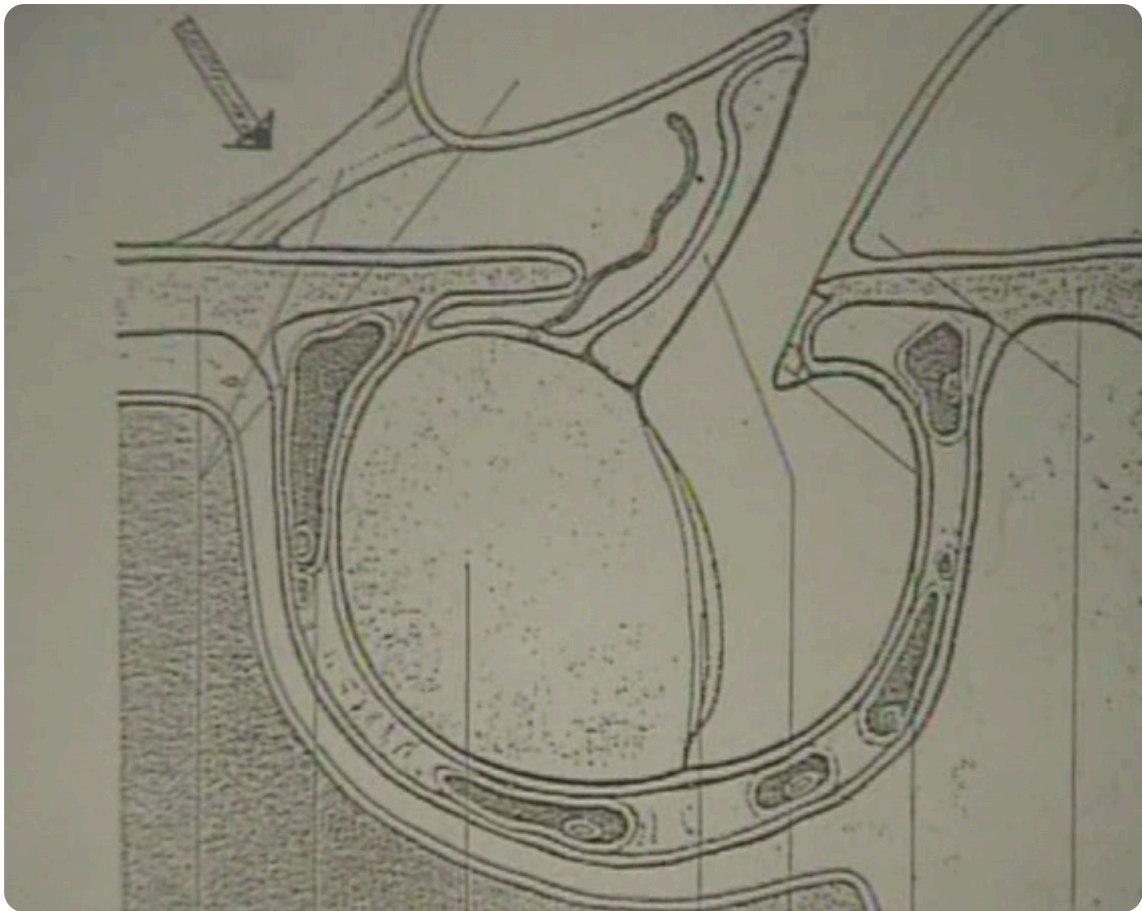


FIG. — *Mouvements coordonnés du crâne, sternum et sacrum*

Tout cela est inscrit dans l'œil, et il est essentiel d'ajouter des éléments concernant le système facial et le système capsulaire de l'œil, qui s'insèrent autour et organisent l'ensemble avec une contre-rotation au niveau du développement de l'orbite.

Les mouvements crânio-sterno-sacrés et mandibulaires sont interconnectés. Les axes canins sont également importants, car ils influencent l'**occlusion**. Si la rencontre canine supérieure et inférieure n'est pas correcte, cela entraîne une perte d'information au niveau du cerveau, car ces champs électriques doivent s'unir.

L'**occlusion** est donc le reflet des tensions présentes sur la **symphyse phénobasilaire**. En observant les dents, il est possible de déterminer la présence de **strain** (tension), qu'il soit vertical, latéral ou autre. Cela permet de comprendre les contraintes et d'ajuster les traitements nécessaires pour rétablir l'équilibre.